

新手健身 100 问

从入门到系统训练 · 科学解答你的所有疑惑

本手册涵盖：训练安排 | 动作技术 | 营养基础 | 补给选购 | 伤病预防 | 心理建设

声明：本文内容基于运动医学、运动营养学公开研究，仅供参考。开始任何新的训练计划前请咨询专业人员。

第 1 部分

Q1: 新手一周练几次比较合适？

建议每周 3-4 次，留出至少 48 小时休息同一肌群。新手神经肌肉适应期（约 4-6 周）需要适度频率建立运动模式，但过度训练会降低依从性和增加受伤风险。推荐方案：全身训练（Full Body）×3 次/周，或上下肢分化 ×4 次/周。

Q2: 我应该先做有氧还是先做力量？

目标决定顺序。目标是增肌增力→先力量后有氧（力量训练在中枢疲劳度最低时完成）。目标是心肺耐力→先有氧后力量。折中方案：分开训练日，力量日和心肺日错开，互不影响。

Q3: 训练前需要热身多久？

5-10 分钟动态热身即可，包括大关节活动（肩环绕、髋关节打开）和轻量特异性动作（如空杆深蹲乘数递增）。静态拉伸建议放在训练后。训练前静态拉伸超过 30 秒会暂时降低肌腱刚度和发力效率。

Q4: 训练后一定要拉伸吗？

建议做。训练后 10-15 分钟静态拉伸加泡沫轴放松，可缓解延迟性肌肉酸痛（DOMS），维持肌肉长度和关节活动度。但注意：拉伸不能阻止 DOMS 发生，只能缓解症状。

Q5: 每次都练到力竭好吗？

不建议。力竭组显著增加中枢神经系统疲劳和受伤风险，且研究显示长期每周练到力竭的训练适应并不优于保留 1-3 次余量的训练。建议：仅在动作组最后一组或特定动作（如辅助引体）安排力竭，日常训练留 1-2 次余量。

Q6: 训练后洗冷水澡还是热水澡好？

冷水浴（10-15°C，10-15 分钟）可减轻炎症反应和 DOMS，但可能轻微削弱长期的肌肉肥大信号（mTOR 通路）。热水浴促进血液循环放松肌肉。共识：训练后先不要立刻极冷极热，等体温自然回落后再温和淋浴。

Q7: 训练时怎么呼吸？

通用原则：离心（放下）时吸气→收缩（用力）时呼气。大重量复合动作（如深蹲、硬拉）需执行瓦式呼吸（Valsalva Maneuver）：用膈肌深深吸气后屏住，腹壁紧张形成腹内压（IAP），保护脊柱，发力完成后再呼气。大重量组不必追求呼吸节奏，安全完成运动最重要。

Q8: 每次训练多久最好？

45-75 分钟为最佳窗口。研究显示超过 75 分钟后皮质醇水平显著上升，合成激素环境下降。效率高于时长：专注于主要复合动作（5-6 个动作）、控制组间休息（60-90 秒），比随意练 2 小时效果好得多。

Q9: 如何记录训练进度？

核心记录三要素：① 动作名称 ② 负荷（kg）×次数×组数 ③ RPE（自感用力度 1-10）。渐进超负荷的关键前提是精确记录。纸笔或 APP（如 Strong/Hevy）均可，关键是坚持。

Q10: 我可以每天都练同一肌群吗？

不可以。肌肉在训练中撕裂分解，在休息中合成修复。蛋白质合成（MPS）的峰值在训练后 24-48 小时，同一肌群至少需要 48 小时恢复窗口。每天练同一部位不仅不增长，还可能导致过度使用损伤。

第 2 部分

Q11: 深蹲应该蹲多深？

对于没有膝关节损伤的健康训练者，建议全范围深蹲（大腿超过平行线）。相比半蹲，全蹲募集更多股二头肌和臀肌，且对膝关节剪切力的影响并不大于半蹲。但若存在髌腱病变或髌关节撞击，蹲至无痛范围即可，不必强求到底。

Q12: 硬拉到底用圆背还是挺直背？

标准回答：训练中用挺直背（脊柱中立位）。圆背硬拉将椎间盘后侧压力显著增加，长期可能诱发腰椎间盘突出。但某些高水平力量举运动员在极限重量时用轻微上背圆（非下背）缩短力臂。新手和中级训练者一律保持中线位。

Q13: 卧推时手腕疼怎么办？

纠正握法：杠铃应落在手掌基部（掌跟线），而非前掌。手腕伸直的侧压握法（通称“假握”或“自杀握”）增加手腕压力且掉杠风险高。正确：四指全握，拇指绕杠锁紧，杠铃在掌跟正上方。如加重后仍疼痛→检查握距和肘部角度。

Q14: 引体向上一个都做不起来怎么办？

降阶方案：① 离心引体（跳起后慢放 3-5 秒）② 弹力带辅助 ③ 高位下拉机（先把基础力量建起来）。每周增加 2-3 次辅助引体训练，多数新手 4-8 周内可完成第一个标准引体。

Q15: 跑步机跑步还是户外跑步好？

跑步机缓冲更好，对膝关节冲击较小（跑带提供回弹），且不受天气影响。户外跑步路况多变、有风和坡度变化，对本体感觉要求更高。各有优劣。初学者建议先在跑步机建立跑姿。

Q16: 什么叫核心收紧？到底怎么收紧？

核心收紧≠吸肚子。正确做法：深吸气后，腹横肌和盆底肌协同收缩，感觉像是准备被人打肚子——腹部变硬但保持呼吸。这其实是腹内压（Intra-Abdominal Pressure, IAP）的形成过程，是脊柱稳定的核心机制。

Q17: 训练时关节弹响正常吗？

分情况：① 无痛弹响（如膝关节泡沫滚动弹响、肩关节无痛弹响）——多为气体逸出或肌腱滑过骨面，生理性无需处理；② 伴有疼痛、卡顿或锁定的弹响——需就医排除半月板撕裂、盂唇撕裂等结构性损伤。

Q18: 为什么我深蹲时膝盖会往前过多？

通常因踝关节背屈活动度不足或胫骨前肌力量弱。分步骤纠正：① 踝关节拉伸（脚踝靠墙伸膝）② 低杠深蹲（重心稍后转移）③ 前蹲或高脚杯深蹲作为变式，强迫躯干更直立。膝盖过前会增大膝关节伸肌力矩，增加前交叉韧带（ACL）剪切应力。

Q19: 哑铃弯举应该用多重的重量？

选择标准：能以标准动作完成 8-12 次且第 12 次接近力竭的重量。对于弯举这类孤立动作，不建议冲极限重量，因为手腕和肘关节易代偿受伤。

Q20: 史密斯机深蹲和自由杠铃深蹲哪个好？

自由杠铃深蹲需要更多核心稳定和协同肌参与，神经肌肉适应效果更好。史密斯机固定运动轨迹，减少稳定需求，对初学者可先过渡，但长期依赖史密斯机会弱化本体感觉和核心控制能力。

第 3 部分

Q21: 增肌每天要吃多少个鸡蛋？

不需要精确到个数。关键是每日总蛋白摄入（1.6-2.2 g/kg 体重）。一个全蛋约含 6-7g 蛋白。蛋黄含膳食胆固醇，但膳食胆固醇对血液胆固醇的影响远小于饱和脂肪和反式脂肪，健康人群每日全蛋 1-4 个基本无虞。

Q22: 减脂期可以不吃碳水吗？

不推荐长期零碳水。碳水是高强度训练的主要燃料来源（糖酵解和糖原分解提供 ATP）。低碳水照常训练会加速糖原耗竭，降低训练强度和容量，反而不利于保肌减脂。推荐将碳水集中在训练前后摄入（peri odization strategy）。

Q23: 训练前吃什么最好？

低脂中等蛋白质中高碳水的组合，训练前 1.5-2 小时。例如：香蕉+2 片全麦面包+一勺蛋白粉。避免高脂高纤维食物（减缓胃排空，训练中可引起不适）。

Q24: 训练后 30 分钟内必须补充蛋白质吗？

不必精确到 30 分钟。近年研究显示肌肉蛋白质合成（MPS）的“合成窗口”实际上更宽——训练后 2-4 小时内补充充分。但因训练、通勤、洗澡等因素，建议尽快吃一顿含 20-40g 蛋白和适量碳水的正餐即可。

Q25: 健身需要喝蛋白粉吗？还是吃饭就够了？

优先从全食物获取蛋白质（肉、蛋、奶、鱼、豆制品），全食物的微量营养素和生物活性物质是蛋白粉无法替代的。蛋白粉是便捷手段——当饮食不足以达到每日蛋白目标（1.6-2.2 g/kg）时使用，而非替代正常饮食。

Q26: 每天喝多少水？

运动营养共识：每日总水摄入量约 3.7L（男性）/2.7L（女性，含饮食水分）。训练前 2 小时饮水 500ml，训练中每 15-20 分钟 150-300ml。注意：不要等到口渴才喝——口渴时已处于 1-2% 脱水，会影响力量输出。

Q27: 减脂期吃米饭好还是吃红薯好？

宏量营养素角度二者相似（都是碳水），红薯膳食纤维稍高、升糖慢，但差异不足以决定成败。更重要的是总热量缺口。选你喜欢且可持续的。

Q28: 训练前后不能吃脂肪吗？

不是不能，但建议把高脂餐安排在训练后 3-4 小时或非训练日。脂肪延缓胃排空速度，可能影响营养利用和高强度训练时的胃肠舒适度。训练前后餐以低脂为宜。

Q29: 我不吃早餐就训练可以吗？

空腹训练（fasted training）对脂肪氧化的影响有限——身体会补偿性燃烧更多脂肪，但全天总热量平衡无差异。一些人空腹训练精力不足影响训练质量。建议实验 2-3 次，感受因人而异。低血糖、低血压者慎空。

Q30: 什么是热量循环/碳水循环？

按训练日/休息日调整热量和碳水摄入：高强度日高碳、休息日低碳或中碳。生物逻辑：训练日糖原消耗后补充，提高糖原利用率；休息日降低碳水摄入制造较轻热量缺口。对非备赛训练者并非必选项，单纯控制总热量已足够。

第 4 部分

Q31: 新手有必要吃肌酸吗？

有。肌酸（Creatine

Monohydrate）是研究最充分的运动补剂，安全性极高。生物学原理：肌酸以磷酸肌酸（PCr）形式储存于肌肉，在短时高强度运动中为 ADP 再磷酸化提供磷酸基团，维持 ATP 供能。新手期补充 3-5g/日可在 3-4 周内提高肌内 PCr 储量 20-40%，显著增加力量增长速度和训练容量。

Q32: 肌酸有副作用吗？脱发、伤肾是真的吗？

① 脱发：肌酸不直接导致脱发。一项涉及橄榄球运动员的 RCT 发现肌酸组 DHT（双氢睾酮）有一定升高但未达统计学显著。对 DHT 敏感且有家族遗传雄激素性脱发者需个别关注，但多数人无影响。② 伤肾：长期（5 年+）每日 5g 肌酸在健康肾脏个体中未见肾功能指标异常。前提是已有肾病者禁用。

Q33: 乳清蛋白和分离乳清蛋白有什么区别？

乳清蛋白（WPC, 70-80% 蛋白含量）通过微滤/超滤保留更多乳糖和脂肪；分离乳清蛋白（WPI, 90%+）额外通过离子交换或微滤进一步去除乳糖和脂肪。对乳糖敏感者，WPI 减少腹胀风险。从蛋白合成角度，WPC 和 WPI 在等蛋白摄入下对肌肉蛋白质合成的刺激效果无差异。

Q34: β-丙氨酸为什么会让脸发麻？

β-丙氨酸通过质子耦合转运体（PAT1/SLC36A1 和 TauT/SLC6A6）吸收入血后，与组氨酸结合生成肌肽。机制：当血中 β-丙氨酸浓度骤增时，可刺激某些感神经末梢的 Mas 相关 G 蛋白偶联受体（MrgprD），引起暂时性皮肤刺痛和泛红。这是无害的组胺样反应，持续约 60 分钟。缓释制剂（TCR）可减轻该反应。

Q35: BCAA 有没有必要买？

当你每日总蛋白摄入 ≥ 1.6 g/kg 时，单独补充 BCAA 无额外增益。原因：亮氨酸通过 mTOR 通路激活 MPS，但需要同时具备其余必需氨基酸。BCAA 缺乏色氨酸等，反而限制了 MPS 的持续。结论：大多数人不需单独购买 BCAA。直接喝乳清蛋白更优。

Q36: 咖啡因真的能提升训练表现吗？

是的。咖啡因是已知的腺苷受体（A1 和 A2A）拮抗剂。腺苷通常在清醒期间积累并促使中枢疲劳——咖啡因竞争性占据受体位置阻断该信号，从而提高警觉性和降低痛感（RPE 下降）。有效剂量 3-6 mg/kg。注意周期性使用避免耐受。

Q37: 鱼油对健身有什么用？

鱼油中的 EPA（二十碳五烯酸）和 DHA（二十二碳六烯酸）是细胞膜磷脂的组成部分，可竞争抑制花生四烯酸代谢通路，减少促炎前列腺素 PGE₂ 和白三烯 LTB₄ 的合成。减轻力量训练后 DOMS 和慢性低度炎症，改善胰岛素敏感性。

Q38: HMB 是智商税吗？

不完全是。HMB 是亮氨酸代谢产物，可通过抑制泛素-蛋白酶体通路（UPS）减少肌肉蛋白分解，并在一定程度上激活 mTOR。对训练新手（前

个月)、减脂期热量缺口大以及老年人肌少症有确切证据。但有经验训练者收益锐减,不值得花高价购买。

Q39: 谷氨酰胺需要补充吗?

对大多数训练者不需要。谷氨酰胺是体内最丰富的游离氨基酸(肌内约 20 mmol/L),内源合成充足。额外补充(通常 10-20g/d)在常规训练者中未见肌肉蛋白合成或增力的额外效应。仅极深度减脂/免疫低下时可考虑。

Q40: 维生素 D 不足会影响训练效果吗?

会。维生素 D 受体(VDR)广泛表达于骨骼肌细胞核。维生素 D 不足时,钙调蛋白介导的肌肉收缩和 II 型肌纤维功能受损。一项 Meta 分析(Tomlinson et al., 2015)发现 D3 缺乏者补充后肌力和平衡功能显著改善。东亚人群因日晒不足普遍缺乏。

第 5 部分

Q41: 深蹲时下背部痛怎么办？

【运动医学建议】首先检查动作模式：杠铃位置是否过高/过低、是否弯腰代偿。如下背部在停止深蹲后仍有持续性疼痛→需排除腰椎间盘突出或小关节紊乱，建议骨科/康复科就诊。如仅为训练后肌肉酸痛→加强核心练习（平板支撑、死虫式），降低负重至无痛水平，逐步重建深蹲模式。

Q42: 我有腰椎间盘突出，还能健身吗？

【△ 必需先看医生】腰椎间盘突出急性期禁止负重训练。康复期（医师评估后）可逐步进行：① 麦肯基伸展练习（俯卧位肘支撑抬上身） ② 核心稳定性训练（死虫式、鸟狗式，注意腹内压维持） ③ 避免坐姿划船、仰卧起坐、传统硬拉等脊柱屈曲受压动作。推荐护具：硬核牛皮腰带可在康复后大重量训练时提供 IAP 支撑，但腰带不是拐杖——核心肌群本身仍需加强。深蹲建议用高杠深蹲或前蹲以减少脊柱剪切力。

Q43: 膝盖有旧伤，可以练腿吗？

【运动医学建议】分受伤类型：① 前交叉韧带（ACL）损伤/重建术后→避免深蹲，可先从器械腿伸展和腿弯举渐进负重，注意避免 0-30° 终末伸展的过度阻力。② 髌腱炎（跑步膝）→降低深蹲幅度至无痛范围，推荐高脚杯深蹲或腿举。护具建议：7mm 氯丁橡胶护膝可提供被动压缩和轻度本体反馈，降低髌腱负荷。但护膝不能替代康复训练。

Q44: 肩关节弹响伴随疼痛怎么办？

常见原因：肩峰下撞击综合征（Subacromial Impingement）或肩袖肌腱炎。【运动医学建议】① 停止所有过头推举动作（杠铃、哑铃）直到评估。② 做特异性筛查：Neer 测试（手臂被动前屈>90° 痛）或 Hawkins-Kennedy 测试（内旋 90° 前屈位痛）→阳性建议 MRI 排除肩袖撕裂。③ 康复动作：Y/T/W 外旋肌力训练、弹力带外旋。充分恢复前勿做大重量卧推和过头推举。

Q45: 跑步时胫骨前侧痛是什么？

可能是胫骨内侧应力综合征（Shin Splints）。发生机制：胫骨后肌和比目鱼肌的牵拉导致骨膜炎症，或骨应力反应。【运动医学建议】① 暂停高冲击活动（跑跳）2-4 周 ② 冷敷、按摩比目鱼肌和胫骨前肌 ③ 检查跑鞋缓冲是否磨损 ④ 恢复跑步时从低里程开始（每周增加≤10%）。如持续疼痛→骨扫描排除应力性骨折。

Q46: 手腕痛做不了卧推怎么办？

【运动医学建议】首先排除三角纤维软骨复合体（TFCC）损伤——如果每次旋转前臂或持重时尺侧疼痛，需就诊。临时方案：① 用哑铃替代杠铃卧推，手腕可自然调整角度 ② 使用推胸机（Smith 或 Nautilus） ③ 握法改为“伪中立”位（掌根承重，手腕微背屈）。推胸护腕可稳定腕关节防止过伸。

Q47: 腰拉伤后多久可以恢复训练？

急性腰扭伤（无神经症状）通常 1-2 周可缓解。恢复阶段：① 急性期（1-3天）→ 休息、冷敷 ② 恢复期（3-7天）→ 无痛范围内核心激活（腹横肌、盆底肌）和行走 ③ 康复期（1-4周）→ 鸟狗式、臀桥、侧桥等动态核心训练 ④ 重返训练→从 50% 负重开始，杠铃硬拉改为六角杠硬拉（减少腰椎力矩）。有神经症状（放射痛、麻木、肌力下降）→立即就诊。

Q48: 健身让我头晕怎么回事？

常见原因：① 瓦式呼吸后站立太快（体位性低血压）→起身前原地踏步 10 秒 ② 低血糖 → 训练前 2h 进食含碳水餐 ③ 脱水 → 检查水量摄入（前文 Q26）。如每次训练皆头晕且伴随视野模糊→需排查贫血、低血压或心源性问题。

Q49: 网球肘能练上肢吗？

网球肘（外侧上髁炎）是伸腕总腱的慢性退行性病变。【运动医学建议】①

暂停抓握和伸腕负重动作（哑铃弯举、引体向上、俯身划船加剧） ② 物理治疗：离心伸腕训练（Tyler Twist 弹力带法） ③ 改练推类动作（卧推、肩推）减少伸腕负荷 ④ 使用推拉保手把或 EZ 杆改变握力角度。恢复约 6-12 周，勿急于重返。

Q50: 练腹肌时脖子痛怎么办？

仰卧起坐和卷腹时用双手抱头拉颈部会导致颈椎屈曲过度，颈长肌和胸锁乳突肌代偿。纠正：①

卷腹时双手轻触太阳穴而非抱头 ② 下巴微收（chin tuck），保持颈椎与胸椎对齐 ③ 改为抬腿卷腹或仰卧举腿 ④ 如持续疼痛→排查颈椎小关节紊乱。腹肌核心训练方式远远不止仰卧起坐。

第 6 部分

Q51: 什么是渐进超负荷？

渐进超负荷 (Progressive

Overload) 是肌肉增长的第一性原则。即逐步增加训练刺激——可以是负重上升、次数增加、组数增加、组间休息缩短或动作难度提高。肌肉适应后不持续增加刺激，生长停滞。

Q52: 我应该用多少 RM 训练？

力量增长：1-5 RM (每组)，间歇 3-5 分钟；肌肥大：6-12 RM，间歇 60-90 秒；肌耐力：12-20+RM，间歇 ≤60 秒。新手不必完全拘泥于区间——覆盖 6-15 RM 范围已能最大化肌肥大适应。

Q53: 练完力量还想加有氧行不行？

可以，但不建议高强度有氧安排在力量训练后，因为糖原储备和神经疲劳已明显。低强度有氧 (快走、椭圆机) 20-30 分钟无妨。高强度间歇 (HIIT) 建议单独训练日安排，以避免干扰力量恢复。

Q54: 我每天都练腹肌还是没有腹肌？

腹肌肉眼可见的三要素 (缺一不可)：① 体脂率足够低 (男性约 12-15%、女性约 18-22% 以下才显现) ② 腹直肌和腹横肌足够强 ③ 骨性结构 (腹白线宽度) 决定对称形状——这部分是基因决定。每天练腹 ≠ 脂肪减少，减脂靠热量缺口。

Q55: 女生练力量会变壮 (变大块) 吗？

不会。女性睾酮水平仅为男性的 1/15-1/20 (约 0.3-1.0 nmol/L vs 男性 10-30 nmol/L)，天生雌激素为主的激素环境使肌肉蛋白质合成对力量训练的反应远弱于男性。女性力量训练的结果是更紧致、线条更好的体型，而非“壮”。

Q56: 训练中途想放弃怎么办？

正常。心理阈值通常出现在每组最后 2-3 次。应对策略：① 减负但做满次数 ② 找个训练搭子互相督促 ③ 听高节奏音乐 (研究显示 BPM 140+ 的音乐可显著降低 RPE) ④ 如果连续 2 周都无动力→检查训练是否过度/睡眠不足/热量缺口太大。

Q57: 我怎么知道该不该加重了？

标准：当前重量能以标准动作完成目标次数上界 (如期待 8-12 次，能在第 12 次仍然有 1-2 次余力) → 加重 2.5-5 kg。加重后应降至该新重量的次数下界 (如降回 8 次)，而非仍然期待 12 次。

Q58: 减脂期力量会下降正常吗？

正常。热量缺口状态下，糖原储备偏低 (糖原每克结合 3-4g 水，减少后可见体重快速下降但力量也降)，肌肉蛋白质合成信号降低。减脂期主要目标不是 PR——维持训练量和强度已很不错。且减脂后期力量下降 5-15% 可以接受。

Q59: 我用 5×5 计划好还是 PPL 好？

新手 (0-6 个月) → 5×5 或全身上下分化更高效 (高频刺激神经适应)。中级 (6 个月+) → 推拉腿 (PPL) 或上下肢分化增加训练量和动作多样性。核心原则：低频但高质量 > 高频但敷衍。

Q60: 如何克服“怕被健身房其他人看”的心理？

绝大多数健身房的人根本不会注意你——他们对着镜子在纠正自己的动作。这是“聚光灯效应”（Spotlight Effect）——高估了他人对自己的关注度。建议：① 戴耳机 ② 去非高峰时段 ③ 提前写好训练计划减少迷茫时间，越自信越不紧张。

第 7 部分

Q61: 新手需要买腰带吗？

大重量深蹲和硬拉时（≥80%

1RM）推荐。腰带通过提供刚性前壁让腹壁可压，显著提高腹内压（IAP），保护脊柱。硬核牛皮腰带（10mm

厚）提供最强支撑，适用于极限重量。推荐厚度

10mm×4

英寸宽。但注意：腰带不是核心肌群的替代品——每组的空杆前几组不要系腰带，保持核心主动收缩。新手建议先练核心 3-6 个月再购入。

Q62: 深蹲用护膝还是绑膝？

护膝（Knee

Sleeves,

5-7mm

氯丁橡胶）：提供被动压缩、本体感觉反馈和轻微回弹性，帮助膝关节在深蹲到底时对齐。适用于日常训练和髌腱炎/膝关节不适者。7mm

厚度提供的回弹力约

5-10kg

深蹲增量（材料力学原因）。绑膝（Knee

Wraps）：弹力布+拉伸缠绕，提供主动回弹。用于极限重量试举，但属竞技用途，日常训练不建议。

Q63: 护腕有什么用？什么时候用？

护腕（Wrist Wraps）在杠铃卧推和过头推举时稳定腕关节于中立位或轻微背伸位，防止过伸姿势下腕骨挤压和

TFCC

损伤。当握推负重超过 80% 1RM 时使用。注意不要绑太紧阻断血供——以手指不发紫不麻木为度。

Q64: 硬拉鞋和深蹲鞋区别大吗？

深蹲鞋（举重鞋，wedge

跟高约

0.75-1

英寸）：EVA/木质跟垫高足跟，代偿踝关节背屈不足，帮助躯干更直立。硬拉鞋：薄而平底（如

Converse

或摔跤鞋），减少鞋底压缩量，缩短力臂。不推荐用跑步鞋做重训（软底 EVA 吸收力且不稳定）。

Q65: 引体向上需要助力带吗？

不需要，除非前臂疲劳已成为限制因素（即背阔肌还有力但握不住杠）。日常训练可用交替握、钩握或

chalk

助握。长周期训练中适度训练握力也是功能肌力的一部分——不应急于用助力带绕过。

Q66: 泡沫轴怎么选？

光滑面（低密度

EVA）：适合新手和痛感敏感者。凸点高密度（网格状）：深层肌筋膜刺激更强（类似于扳机点释放）。建议从低密度开始，逐步过渡到高密度。不要直接拿狼牙棒式的滚大腿根部——神经束丰富，过度压迫可致麻木。

Q67: 训练服应该穿紧身的还是宽松的？

紧身衣（压缩类）：提供浅层本体感觉反馈、减少肌肉晃动。宽松衣：舒适排汗、不影响关节活动。从生物力学角度无本质区别，取决于个人喜好。注意：训练裤不要太长，避免绊倒。

Q68: 大重量硬拉需要腰带+助力带都戴吗？

可以，但建议做组时先只戴腰带——让握力参与训练。只在最后

1-2

个极限组使用助力带辅助握力。引体向上同理。交替使用钩握可减少拇指疲劳。

Q69: 护具训练中必须一直戴着吗？

不。正确做法：热身组和轻量组（ $<60\%$

1RM）不戴护具，让核心和关节本身参与稳定。只有接近极限重量的最后几组才戴腰带/护膝/护腕。长期依赖护具会弱化本体感觉和核心肌群。

Q70: 什么是减震鞋垫？有必要吗？

减震鞋垫通过微观孔隙结构（如

Sorbothane

凝胶）分散足底冲击力，对跑步和跳类训练有用，但对力量训练（需足底稳定）反而不利——压缩回弹产生不稳定底座。重训时穿平底硬鞋；跑步时穿缓冲鞋。一鞋不能通吃。

第 8 部分

Q71: 女性生理期能健身吗？

可以。研究显示女性在生理期内适度的中低强度训练（如瑜伽、快走、轻量上肢）不仅安全，还可缓解经痛和疲惫。但应调整强度——高负荷深蹲和硬拉不建议。研究表明月经周期黄体期（约第 14-28 天）肌肉力量通常略高于卵泡期，可相应安排训练强度。感受个体差异大，听从身体信号。

Q72: 女性练深蹲会粗大腿吗？

会一定程度增加大腿围度——但这是女性下肢力量的基础。如果不想要额外的股四头肌发展，可用臀桥、髋推（Hip Thrust）和单腿罗马尼亚硬拉替代深蹲，更侧重臀肌而减少股四头肌参与。女性长肌肉的速度仅为男性 1/10-1/20——不必担心练一练就太壮。

Q73: 怀孕期间可以继续健身吗？

可以，但需调整并咨询产科医师。安全的孕期运动包括：快走、游泳、固定自行车、孕期普拉提和低强度力量训练。禁忌：腹部受压动作、大重量负重、跳/蹦类冲击运动、长时间仰卧位（妊娠 20 周后）。

Q74: 坚持 2 周没变化，正常吗？

完全正常。肌肉肥大和力量增长在 4-6 周内才会出现显著可测量变化。前 2 周主要是神经肌肉适应——大脑学习高效募集运动单位。所以坚持看不到变化的阶段，其实你的神经系统正在变得更高效。

Q75: 健身要坚持多久才能看到明显效果？

力量层面：2-4 周可见力量提升（神经适应）。肌肉围度层面：6-8 周开始肉眼可辨。体脂下降：取决于缺口大小，通常 4-6 周可见体重变化和身体围度缩小（拍照对比而非单看体重秤）。

Q76: 健身一定要去健身房吗？

不一定。自重训练（俯卧撑、深蹲跳跃、引体向上）加上弹力带/一对哑铃，同样可以取得好的增肌效果和心肺增强。但健身房提供了更自由的负重选择和隔离肌群的器械——这在后期渐进超负荷时更方便。根据预算和偏好决定。

Q77: 我怎么知道训练频率对吗？

信号：① 每个肌群每周 2 次训练频率（上下分化或全身训练）对新手理想。② 训练后 24-48 小时恢复到可以再次训练该肌群的状态。③ 如果每次训练时该部位仍然酸痛→间隔时间不够或训练量过大。调低组数量。

Q78: 增肌期可以一直吃脏增肌吗？

脏增肌（随意吃高热量食物来增重）虽然热量易超标，但增加的脂肪比例远高于干净增肌。每多 1kg 肥肉后续减脂需多花 2-4 周时间。建议：热量盈余 300-500 kcal/d，蛋白质达标，脂肪和碳水占总热量的比例控制在合理区间（20-35% 脂肪，剩余碳水）。

Q79: 减脂期为什么要吃足蛋白？

热量缺口下，身体倾向于分解蛋白质（肌肉）作为能量来源。摄入充足蛋白（2.3-3.1 g/kg/d）可通过亮氨酸信号和胰岛素升高保留肌肉蛋白质合成（MPS）水平，最大化减脂期间保肌率。同时蛋白有更高的食物热效应（TEF，约 20-30%，碳水和脂肪约 5-15%）。

Q80: 喝酒对健身影响大吗？

较大。酒精代谢产物乙醛会直接抑制 mTOR 信号通路和 MPS，单次中等量饮酒（3-4 标准杯）可使训练后 MPS 降低约 20-36%。酒精还抑制抗利尿激素（ADH）→利尿排水→脱水→肌肉泵感降低。不建议训练后饮酒。尽量少饮酒。

第 9 部分

Q81: 健身会让新陈代谢变快吗？

会。力量训练增加的瘦体重（LBM）每 kg 每天约消耗 13-15 kcal 基础代谢。相比脂肪组织约 4.5 kcal/kg/d。中高强度有氧后还有运动后过量氧耗（EPOC）效应，持续数小时使代谢略有升高。综合来看健身者比久坐者每日多消耗 200-400 kcal。

Q82: 练肌肉的时候真的有在“撕裂”吗？

是的。离心收缩导致的机械张力引起 Z 线和肌原纤维微损伤（microtears），触发卫星细胞激活和修复响应。这个过程产生 DOMS 和肌酸激酶（CK）释放入血。24-72 小时后，修复完成并超量恢复（Supercompensation），肌肉变得更强。

Q83: 为什么练完腿第二天走路都困难？

典型的 DOMS（延迟性肌肉酸痛），由肌肉微损伤和继发性钙离子内流介导的炎性反应引起。通常 24-48 小时达峰值，72 小时后消退。如果超过 5 天仍未缓解或伴有明显肿胀和尿色变深→排除横纹肌溶解症（Rhabdomyolysis）。减轻方法：低强度活动、泡沫轴、温水。

Q84: 什么叫“代谢适应”？减脂后期不掉秤了？

减脂期体重下降后，基础代谢（BMR）和总能量消耗（TDEE）随之降低（因为体重变小、激素环境改变和体能活动减少）。这叫代谢适应（Metabolic Adaptation），是身体的自我保护机制。应对方法：① 重新估算 TDEE ② 安排饮食休息周（Diet Break，恢复吃到维持热量 1-2 周）③ 增加 NEAT（非运动性日常活动，如增加步行步数）。

Q85: 为什么健身初期体重反而上升了？

正常现象。力量训练导致肌肉内糖原储备增加（每 g 糖原结合 3-4g 水），总计可增加 1-2kg 水分存留。这并不代表变胖了。持续 4-6 周后体重变化将反映真实的脂肪增减。不要被体水分波动干扰信心。

Q86: 什么是 deload 周？一定要做吗？

Deload（减载周）是指每 4-8 周安排 1 周训练量和强度减半，给神经系统和肌肉关节充分恢复。证据显示 deload 可以降低累积疲劳（降低皮质醇水平），恢复时超量恢复水平更高。即使是顶尖运动员也需要周期化减载。

Q87: 训练到多久可以开始用高级训练方法（超集、递减组）？

至少 6-12 个月基础训练经验后。超集/递减组/离心加强等方法增加训练密度和疲劳度——但对新手来说，标准组即可取得充分进步。在不必要的时候用高级方法反而限制容量和恢复。

Q88: 什么是垃圾容量？

指以糟糕动作模式完成、神经控制几乎完全依赖于摇摆/反弹借力来完成次数的那几组。垃圾容量不仅弱化正确模式，还无谓增加关节和肌腱劳损。标准：每个动作的最后一次与前一次的轨迹和速度应一致。

Q89: 到底要不要请私教？

建议在前 1-3 个月内请一节私教课，主要学习：深蹲、卧推、硬拉、过头推举、引体向上/划船这五个核心动作的标准模式。自学风险在于动作模式固化为错误后较难纠正，且受伤风险上升。好私教应该教你原理和自纠能力，而非一直依赖。

Q90: 同一个动作每次都要做同样的次数和重量吗？

不是。线性周期进阶（每次加重）是初期的核心策略，但每 4-6 周应更换动作变式（如高杠深蹲 ↔ 低杠深蹲、平凳卧推 ↔ 上斜卧推）以提供不同的刺激角。双分化周期（强度日/容量日交替）也是更高效的策略。

第 10 部分

Q91: 训练时听音乐效果好吗？

研究表明 BPM 120-145 的音乐可降低自感用力度（RPE）约 10%，且同步运动节奏可改善神经肌肉效率和力量输出。但训练中过度依赖音乐=在不受控环境中（比赛/无音乐场地）表现下降。适度用但不要依赖。

Q92: 睡眠不足会影响训练吗？

显著影响。睡眠剥夺（<6 小时）导致皮质醇升高和睾酮下降，降低训练时 MPS 信号和糖原再合成效率。一晚睡眠 < 5 小时相当于降低了约 20% 力量输出。训练效果 = (训练质量 × 睡眠质量) / 压力。睡眠是“免费补剂”。

Q93: 健身后多久可以吃饭？

建议 30-90 分钟内安排一次含蛋白和碳水的正餐/加餐。这不是因为什么“代谢窗口”的紧急性——而是因为补充糖原和氨基酸有利于下一训练日的恢复。延后 2-3 小时进食也并不会浪费训练—— MPS 窗口没那么窄。

Q94: 吃肉=长肌肉？那吃素能健身吗？

能。植物蛋白的不同来源（豆类+谷物）组合可提供完整氨基酸谱。素食者的肌酸和肌肽水平通常低于杂食者，可通过肌酸和β-丙氨酸补充。但素食者需更注意铁、锌、B12、维生素 D 的摄入。已有多位高水平 vegan 举重运动员存在。

Q95: 拉伸能改善肌肉不对称吗？

不能直接纠正。肌肉不对称大多是神经控制偏侧（惯用手更发达）或长期不良姿势所致。纠正方法：① 单侧训练（单臂划船、单腿深蹲、单腿臀桥）优先弱侧 ② 比对称重量少 10-20% 的负重开始弱侧训练 ③ 镜子或手机录像检查动作是否存在旋转偏移。拉伸能改善活动度但不直接影响肌力不平衡。

Q96: 健身为什么要练复合动作而非全是孤立动作？

复合动作（深蹲、硬拉、卧推、划船、引体向上）调动多关节和多个肌群，产生更高水平的神经内分泌反应（较明显的生长激素和睾酮脉冲分泌）和更大的总能量消耗。复合动作作为主体、孤立动作作为补充——顺序上先复合后孤立。

Q97: 我怎么知道自己的训练量是否合适？

每周训练量（每肌群组数×次数×负重）的调整信号：① 如果每周力量没有小幅进步→量可能不足 ② 如果持续疲劳、睡眠变差、受伤→量可能过大 ③ 标准参考：新手每肌群每周 10-15 组，中级 15-20 组，高阶 20-25 组。从低限开始逐步增加。

Q98: 蛋白粉和增肌粉有什么区别？

增肌粉（Mass Gainer）= 蛋白粉 + 大量碳水化合物（麦芽糊精）+ 少量脂肪。本质上是为了在较少胃容量下提供高热量。但绝大多数增肌粉的碳水来源是精加工淀粉（快速吸收型），不如全食物（燕麦、米饭、红薯）的营养价值。除非你一天需要 4000-5000 kcal 且吃不下那么多全食物，否则不建议买增肌粉。蛋白粉+自己配碳水组合更优更经济。

Q99: 如何判断健身补剂是否靠谱？

三步验证法：① 查成分：是否有第三方检测认证（Informed-Sport、NSF Sport、USP Verified） ② 读文献：在

看标签：成分剂量是否透明标注，有无“专有混合物”隐晦标签。如果产品以各种玄学故事来卖药丸而非以科学证据——那就是营销而非补剂。

Q100: 送给出新手——最重要的三条建议？

第一，坚持比强度重要。每周 3 次 × 持续半年 > 每天练 2 小时 × 坚持 1 个月。第二，动作质量优先于重量。错误模式下的重量是走向伤病的捷径而非进步的阶梯。第三，接受缓慢。肌肉一年最多自然增长 1-2 kg（男性）和 0.5-1 kg（女性）。健身是跟自己的比赛，不是跟别人的滤镜比。祝你找到持续训练的理由，而不是三天打鱼的理由。